血管エコー検査を契機に巨細胞性動脈炎と診断された一例

◎三上 彩花[1)]、西田 秦剛[1)]、手丸 恵美[1)]、門島 璃奈[1)]、宮脇 美月[1)]、髙田 ちづる[1)]、山岸 拓巳[1)]、本木 直樹[1)]
富山赤十字病院[1)]

【はじめに】超音波検査は非侵襲的で痛みもなく比較的短時間で様々な臓器を検査できる。今回、造影 CT で所見は認めなかったが、血管エコー検査を契機に巨細胞性動脈炎と診断された一例を経験したので報告する。

【事例】68 歳男性。咽頭痛で近医耳鼻科を受診し対症療法となる。そこから右耳下～右後頭部の腫脹・疼痛が出現し、抗菌薬を処方されるが疼痛悪化。さらに、発熱、頭痛も出現したため近医内科を受診。頭痛継続、炎症反応の改善が認められないため当院内科に紹介となった。紹介時の単純ＣＴでは唾液腺腫大やリンパ節腫大等は認めず、抗菌薬が部分的に奏効している可能性を考えて急性唾液腺炎を念頭に ABPC/SBT での治療が始められた。しかし治療開始 5 日後には、視覚障害や右側頭動脈の怒張が顕在化、圧痛も認めるようになった。巨細胞性動脈炎も鑑別の 1 つに挙げられるため頸動脈エコー、造影ＣＴを実施。エコー検査にて右側頭動脈優位に dark halo を認めた。後日生検を行い、巨細胞性動脈炎の診断に至りＰＳＬでの治療が開始された。

【考察】巨細胞性動脈炎は難病に指定され、患者数も 2017 年の全国疫学調査で約 3,200 人と少ない疾患である。咽頭痛から始まり頭痛、側頭動脈の怒張や視覚障害が徐々に顕在化した本症例のように、その症状も多岐にわたるため、耳鼻科、歯科、眼科で初診となることも珍しくはない。そのため、巨細胞性動脈炎を早期に鑑別疾患に挙げることは難しいと思われる。
巨細胞性動脈炎の分類基準の 1 つに「側頭動脈の異常」がある。エコー検査での感度は約 40％と言われ、発症初期には dark halo を認めないこともある。しかし、本症例では造影 CT では得られなかった所見をエコー検査で得ることができ確定診断に繋げることができた。今回、側頭動脈の怒張と視覚障害を契機に血管エコーを実施するに至ったが、エコー検査の簡便さから内科に関わらず他科でも積極的に検査を取り入れることで早期に診断へと繋げられる可能性を秘めていると考えられた。